参 考 文 献

[1] 赵林芳，曹秀珠，曾旭芬．双腔起搏器植入患者使用腔内心电图引导 PICC 异位调整的护理 [J]．护理与康复，2020，19（7）：58.

[2] JI S H，YOO S J，CHO S A，et al. Ultrasound-guided insertion of peripherally inserted central catheter after anesthetic induction in children undergoing surgery for moyamoya disease - Thirty cases report[J]. Anesth Pain Med（Seoul），2021，16（3）：273.

[3] 金静芬，陈春芳，赵锐祎，等．经外周穿刺置入中心静脉导管异位处理方法的研究进展 [J]．中华护理杂志,2013,48(2)：184.

[4] 鲍晨晨．PICC 导管异位颈内静脉的预防与处理研究进展 [J]．实用临床护理学电子杂志，2020，5（12）：197.

[5] 胡伟，吴书楷，张丽娜，等．超声引导下左右臂 PICC 置管颈内静脉异位发生率的差异性研究 [J]．护理与康复，2022，21（1）：32.

[6] 孙凤凤，李东亮，康秀文．多功能半卧位装置联合导管漂移原理在机械通气患者中置入 PICC 的应用 [J]．国际护理学杂志，2023，42（8）：1433.

[7] 赵锐祎，谢彩琴，曹素娟．25 例 PICC 异位的原因分析与护理对策 [J]．中华护理杂志，2009，44（6）：526.

[8] 何惠琴，张素丽，储文雅，等．后撤不同长度导丝对 PICC 置管异位率的影响 [J]．护士进修杂志，2020，35（17）：1629.

[9] 张雪雪，李娟，陈晓琪．对 12 例 PICC 异位患者进行侧卧位复位的效果观察 [J]．求医问药（学术版），2012，10（12）：712.

[10] 易纪津，姜东梅，成丽芳，等．不同体位脉冲式冲管在调整新生儿 PICC 置管导管异位中的应用研究 [J]．中国医学创新，2019，16（5）：118.

[11] 张亚需，李娜，张蓉芳，等．手法复位配合等渗盐水冲管在新生儿 PICC 异位复位中的应用 [J]．护理与康复，2020，19（1）：50.

[12] 宋敏，王秀丽，高大雁，等．置管对侧偏头法在 PICC 患者置管中的应用 [J]．中国实用护理杂志，2022，38（14）：1069.

[13] 邵乐文，胡晓蓉，金爱云，等．113 例肿瘤患者 PICC 置管过程中导管异位的识别与复位 [J]．中华护理杂志，2018，53（4）：454.

（收稿：2023-09-18　修回：2024-05-20）

（本文编辑：任红璞）

华法林过量致出血性休克的心房颤动并发缺血性脑卒中 1 例护理

罗银霞

【关键词】　华法林；出血性休克；心房颤动；脑卒中；失语症；护理

DOI：10.19542/j.cnki.1006-5180.2311-463

心房颤动是脑卒中和栓塞最常见的危险因素。华法林是目前临床应用最广、适应证最多、循证医学证据最充足的口服抗凝药，已广泛用于预防心脏瓣膜置换术后血栓，以及心房颤动、深静脉血栓的防治等[1]。但华法林是一种治疗窗狭窄的双香豆素衍生物，当治疗量未达标时会增加血栓形成风险，而超治疗量时会增加出血风险，同时个体药物剂量需求差异性较大[2]。2023 年我院收治华法林过量致出血性休克的心房颤动并发缺血性脑卒中患者 1 例，经过精心治疗与护理，最终康复出院，现总结护理体会如下。

1　病历摘要

患者女，76 岁，主诉“反复胸闷、气促 10 余年，便血 3 d 伴晕厥”于 2023 年 2 月 4 日入院。患者既往心房颤动病史多年，予华法林抗凝治疗，但未规律口服。国际标准化比值（INR）7.91 ↑，凝血酶原时间（PT）83.6 s ↑。诊断：抗凝药中毒（华法林过量）；休克；下消化道出血；风湿性心脏瓣膜病；心房颤动；高血压。急诊予以维生素 K_1、输血、升压等处理。2 月 5 日，INR 5.26 ↑，PT 58.4 s ↑，继续对症处理后收治我科。查体：T 37.3 ℃，P 116 次 /min，R 24 次 /min，BP 96/58 mmHg。患者精神软，口唇无发绀，两肺呼吸音粗，心律绝对不规则，心尖区 2 级收缩期杂音，双下肢无水肿。2 月 6 日，血红蛋白 94 g/L ↓，脑钠肽 203 ng/L ↑，INR 3.15 ↑，PT 35.4 s ↑。2 月 7 日，患者解黑色大便 1 次，约 150 mL，无呕血、腹痛，活动后稍有胸闷、气促，INR 2.17 ↑，PT 25 s ↑，血红蛋白

作者单位：312000　浙江绍兴第二医院医共体总院心内科

通信作者：罗银霞，Email：376275009@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

61 g/L ↓。粪便隐血试验结果阳性。遵医嘱输注去白细胞悬浮红细胞 1 U。2 月 9 日，患者精神面貌好转，血红蛋白 91 g/L ↓，INR 1.10，PT 12.8 s，复查粪便隐血试验弱阳性，19：50 发现语言障碍、右侧上肢不灵活，予神经内科会诊。

查体：失语，右侧肢体肌力约 4 级，右侧巴宾斯基征阳性，即刻完善头颅 CT 未见出血，CT 血管成像未见明确大血管急性闭塞，考虑急性脑卒中。患者因消化道出血入院，溶栓禁忌，粪便隐血试验弱阳性，血红蛋白尚平稳，予继续抗凝、适当补液治疗。2 月 11 日，患者能发声，但言语含糊，右侧肢体肌力约 4 级。2 月 14 日，患者口齿较前清楚，左侧肌力正常，右侧肢体肌力恢复至 5^- 级，无头晕、头痛，无胸闷、气促，予出院。

2 护理

2.1 严密观察病情变化

长期服用华法林的患者发生消化道出血的概率为 5% ～ 15%[3]。为预防消化道出血致休克，措施如下：① 患者保持合适体位，抬高床头 20 ～ 30°、床尾 15 ～ 20°，以增加回心血量，改善脑血流。予鼻塞吸氧 3 ～ 4 L/min，保持呼吸道通畅。② 每半小时监测生命体征，评估患者意识、面色、末梢循环、尿量等。血压、心率、血红蛋白等数据以折线图形式展示，动态观察生命体征变化，及时发现患者是否发生循环波动。③ 责任护士收集患者头晕、乏力、腹部不适、出冷汗、心悸等主诉，警惕有出血及休克征兆。④ 随时做好抢救准备，抢救车、吸痰器等抢救设备备至床旁，开通至少两条静脉通路，用于输血、补液。患者入科后连续 3 d 解黑便，血红蛋白下降，原有高血压病史，现血压 86/52 mmHg，血压及血红蛋白折线图呈明显下降趋势。患者表现为面色苍白，感乏力明显。为纠正休克，遵医嘱予配置生长抑素、间羟胺、艾司奥美拉唑钠持续微泵输注，输注去白细胞悬浮红细胞 1 U、补液治疗。同时，根据血压、尿量等监测结果，及时调整输液方案。患者精神好转，休克得到纠正。

2.2 急性脑卒中后失语症的护理

脑卒中失语症发生率为 21% ～ 38%[4]。如不尽早介入康复治疗，40% 的卒中后失语症患者语言功能很难自发恢复[5]。在常规药物治疗的基础上，制定语言康复计划：① 由主治医生、康复师、责任护士组成语言康复治疗小组。主治医生负责病情评估；康复师进行失语症的功能筛查及评估，制定具体的康复计划；责任护士负责语言康复计划的具体实施。② 根据患者的文化、环境、家庭、兴趣等资料制定康复训练干预方案。a. 听力训练：患者文盲，平时喜欢看电视，播放患者感兴趣的电视节目，每次 30 ～ 40 min，每日 2 次，在播放过程中与患者交流。b. 认知功能训练：制作图片及照片沟通交流板，如喝水、睡觉、洗澡、穿衣等日常生活照片；粥、米饭、苹果、香蕉等日常食物图片，传递患者想表达的信息。c. 发音训练：让患者用唇部做反复伸缩锻炼，用舌头做反复旋转训练，发简单音。患者平时喜欢打牌，借助纸牌利用镜像疗法，展示口型结合手势，让患者模仿。d. 口语表达训练：鼓励家属讲些患者感兴趣的话题，患者经历的事情，刺激患者的记忆力，增强患者的表达欲望，用简单发音和手势进行交流。e. 注意力训练：找不同图片从简单对比开始，逐渐提高训练难度。③ 做好动态评估：密切跟踪患者的康复治疗进展，应用日常生活交流能力评定法来评估训练效果，根据情况随时调整康复方案。患者出院时口齿较前清晰，日常生活交流能力评分原来 37 分，现为 82 分。

2.3 急性脑卒中的早期肢体康复护理

急性脑卒中是一组器质性损失的脑血管疾病，伴有语言及神经功能障碍，具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率、高经济负担五大特点[6]。研究指出[7]，脑卒中患者早期进行肌力训练，可有效对抗肌力减退。本例患者发生急性脑卒中后左侧肌力 5 级，右侧 4 级，发病 24 h 后予循序渐进地进行康复训练。卧床期间：督促患者至少每 2 h 翻身 1 次，避免同一部位长时间受压；保持良姿位，以预防关节粘连、挛缩；使用软硬适中的枕头支撑踝关节、膝关节，避免下肢内翻、外旋。监测生命特征平稳后进行床边康复、早期离床肢体康复训练。上肢功能训练：自主喝水、梳头、吃饭、穿脱外衣。上肢负重练习：举哑铃、抓吸盘等。躯干训练：侧卧位坐起、站立平衡训练等。下肢功能训练：床边踏步、适当距离步行、迈台阶训练等。以上训练都在责任护士的陪同下进行，训练每天 3 次，每次 15 ～ 20 min。患者出院时左侧肢体肌力正常，右侧肢体肌力恢复至 5^- 级。

2.4 早期识别再出血与血栓预防

华法林作为心房颤动预防血栓的首选药物，也会发生出血事件。本例患者因口服华法林过量致消化道出血休克，立即停用华法林，予维生素 K_1 肌注，3 d 后仍解黑便，粪便隐血试验结果阳性。在纠正相应的出血原因及控制好出血危险因素后，至少 4 周才考虑重新启动抗凝治疗[8]。但该患者在停用华法林 5 d 后出现急性脑卒中表现。遵医嘱再次启用依诺肝素钠 + 华法林抗凝治疗。抗凝相关消化道出血患者出血停止后恢复抗凝治疗，可降低血栓栓塞率和死亡率，但提高再发消化道出血率[9]。每半小时观察患者意识及情绪变化，记录生命体征，监测 PT、INR 及血红蛋白的动态变化，警惕新发的出血或栓塞。预防出血措施如下：① 注意观察患者

中国知网 https://www.cnki.net

大便及尿液颜色变化，排便后仔细询问粪便的形状、颜色、量等情况。② 护理操作时动作宜轻柔，观察穿刺点周围有无出血、渗血，口鼻出血和全身皮肤黏膜有无散在瘀点或瘀斑。③ 遵医嘱禁食期间做好口腔护理，出血控制后给予米汤、蔬菜汁、水果汁等温凉流质饮食，恢复正常饮食后进食粥、面条、藕粉等易消化的食物，保持大便通畅。预防血栓措施如下：① 卧床休息期间，指导患者有效深呼吸及咳嗽训练；教会患者做踝泵运动、膝关节伸屈运动；B 超提示下肢深静脉无异常时，予腿部气压治疗 30 min，2 次 /d；鼓励多饮水。② 患者病情稳定后予早期下床活动。药剂师根据本例患者情况再次启用华法林的初始计量为 1.875 mg/d，出院时患者无再次出血及栓塞事件的发生。

2.5　家属参与式认知干预以提供心理支持

家庭关怀度是个体对家庭功能的满意度情况，良好的家庭关怀可减轻患者心理压力，以积极、乐观的心态来面对疾病 [10]。使用焦虑自评量表、抑郁自评量表评估患者的心理状况。本例患者存在中度抑郁和焦虑。患者认为自己年龄大，基础疾病多，后期又并发失语症，无法准确表达，对疗效缺乏信心。采取措施如下：① 护患双方多次沟通，告知病因及预期疗效，避免患者因对疾病了解不够过于恐惧，造成治疗积极性降低。② 鼓励家属与患者建立积极有效的沟通，特别是在失语期，通过微表情及动作语言，及时满足患者生活上和情感上的需求，提升患者的家庭关注度，营造和谐家庭氛围。③ 发放心房颤动、脑卒中患者家属健康指导手册，进一步了解疾病、饮食、康复等相关内容。④ 指导患者学会自我放松，有效深呼吸、肌肉放松等。通过收看电视节目、与家属聊天等方式转移患者注意力。本例患者出院前再次评估心理状态，转为轻度。

2.6　做好延续性护理

移动健康指利用移动设备和技术，如智能手机、移动应用程序和平板电脑等，提供健康服务和管理的方法 [11]。研究发现 [12]，心房颤动患者的服药信念、疾病感知对其华法林自我管理的影响不容忽视。本例患者在家已便血 3 d 至休克，入院时查 INR 7.91，说明患者及家属对疾病和药物的知识极度缺乏。加强健康宣教，措施如下：① 由临床医师、康复师、药剂师、心理师、随访护士组建微信群和随访系统，包括在线答疑、定期发送健康宣教内容，提高患者服药依从性及生活质量。② 利用新媒体视频平台，制作宣教视频，提高患者知识水平。③ 利用综合管理网站，通过文本和视频推送抗凝药物说明书及心房颤动、失语症相关知识，并设有专业咨询功能，强化对患者的院后护理，尤其是药物不良反应监测。④ 建立出院患者复查详细电子档案，及时登记患者抗凝情况，若未定时复查，及时电话回访。⑤ 患者若复查困难，推荐使用“互联网 + 浙里护理”。本例患者及家属配合良好，出院后经过半年随访，未出现并发症。

参　考　文　献

[1] 况赟，宋珑，孙媛媛，等．华法林个体化治疗独立指南的现状分析 [J]．中国临床药理学杂志，2022，38（17）：2084.

[2] ABDELNABI M，BENJANUWATTRA J，OKASHA O，et al. Switching from warfarin to direct-acting oral anticoagulants：it is time tomove forward！ [J]. Egypt Heart J，2022，74（1）：18.

[3] 胡梦瑶，寇继光．口服华法林期间消化道出血患者的桥接抗凝治疗的安全性及有效性 [J]．临床消化病杂志，2020，32（6）：358.

[4] GINEX V，GILARDONE G，VIGANO M，et al. Interaction between recovery of motor and language abilities after stroke[J]. Arch Phys Med Rehabil，2020，101（8）：1367.

[5] STAHL B，DARKOW R，PODEWILS V V，et al. Transcranial direct current stimulation to enhance training effectiveness in chronic post-stroke aphasia：a randomized controlled trial protocol[J]. Front Neurol，2019，10（19）：1089.

[6]《缺血性脑卒中（大动脉粥样硬化型）治未病干预指南》编写组，北京中医药大学东方医院．缺血性脑卒中（大动脉粥样硬化型）治未病干预指南 [J]．北京中医药大学学报，2023，46（8）：1076.

[7] 李燕，黄丽华．老年人平衡能力评估及干预的研究进展 [J]．中华护理杂志，2019，54（4）：603.

[8] 周英．心房颤动患者发生抗凝相关出血后重启抗凝治疗的研究进展 [J]．海南医学，2019，30（15）：2017.

[9] 黄睿琦．抗凝相关消化道出血患者恢复抗凝治疗安全性及最佳时机的 meta 分析 [D]．重庆：重庆医科大学，2023.

[10] 谭琳，陈丽，王延芬，等．缺血性脑卒中患者心理一致感与反刍性沉思、家庭关怀度的关系研究 [J]．护理管理杂志，2021，21（11）：774.

[11] BERNARD R M，SEIJAS V，DAVIS M，et al. Mobile Health Self-management Support for Spinal Cord Injury：Systematic Literature Review[J]. JMIR Mhealth Uhealth，2023，26（11）：e42679.

[12] 王广宁，崔岩，杨富国，等．房颤患者华法林自我管理现状及影响因素调查 [J]．护理学杂志，2019，34（11）：5.

（收稿：2023-11-27）

（本文编辑：陆　易）

中国知网　https://www.cnki.net